

Nomor : PP.05.01/F.XIII/1151/2026 12 Februari 2026
Lampiran : 1 (Satu) Exp.
Perihal : Ijin Menggunakan Lahan Praktek Klinik Keperawatan & Penunjukan Pembimbing bagi Mahasiswa Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Malang Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Malang Semester Genap TA 2025/2026 (Kelas RPL)

Kepada Yth:
Direktur RS Prima Husada Sukorejo
Jl. Raya Surabaya - Malang No.Km.54, Palang, Lemahbang, Kec. Sukorejo
di –
Sukorejo

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Praktek Klinik Keperawatan bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Malang Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Malang Semester VIII Tahun Akademik 2025/2026 (Kelas RPL), maka bersama ini kami bermaksud mohon ijin untuk menggunakan RS Prima Husada Sukorejo sebagai tempat yang dapat memfasilitasi mahasiswa praktek sebagai berikut:

No.	Lahan Praktek	Kompetensi	Tanggal Pelaksanaan	Jml. Kelp.
1.	RS Prima Husada Sukorejo	• Kep. Gawat Darurat & Kritis • Kep. Paliatif • Kep. Perioperatif	20 April – 06 Juni 2026	1 klp (1 mhs)

Adapun Program dan Jadwal Praktek Klinik Keperawatan terlampir.

Untuk memperlancar kegiatan tersebut, kami mohon ditunjuk Pembimbing dari masing-masing ruangan yang nama-namanya dapat dikirim bersama surat balasan persetujuan penggunaan lahan pada **email: jurusankeperawatanpolkesma@poltekkes-malang.ac.id**

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Plt. Direktur
Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes
malang,



Dr. Erlina Suci Astuti, S.Kep, Ns, M.Kep
NIP 197608102002122001

- Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang
 2. Ka. Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Malang
 3. Ka. Bid. Diklat RS Prima Husada Sukorejo
 4. Ka. Bid. Keperawatan RS Prima Husada Sukorejo
 5. Ka. Ruang: ICU, Paliatif, IBS RS Prima Husada Sukorejo



PROPOSAL

**PRAKTEK KEPERAWATAN GAWAT DARURAT DAN KRITIS
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN MALANG
JURUSAN KEPERAWATAN POLTEKKES KEMENKES MALANG
SEMESTER VIII TAHUN AKADEMIK 2025/2026 (KELAS RPL)**



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN MALANG
JURUSAN KEPERAWATAN
TAHUN 2026**

**PROPOSAL PRAKTEK KEPERAWATAN GAWAT DARURAT DAN KRITIS
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN MALANG
JURUSAN KEPERAWATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG
SEMESTER VIII TAHUN AKADEMIK 2025/2026 (KELAS RPL)**

1. DISKRIPSI

Praktik klinik keperawatan gawat darurat dan kritis merupakan program yang menghantarkan mahasiswa dalam adaptasi profesi untuk menerima pendelegasian kewenangan secara bertahap dalam melakukan asuhan keperawatan, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi pada klien, membuat keputusan legal dan etik serta menggunakan salah satu referensi dari hasil penelitian yang berkaitan dengan keperawatan gawat darurat dan kritis.

Praktik Klinik Keperawatan Gawat darurat mencakup asuhan keperawatan dalam konteks keluarga pada klien dengan berbagai tingkat usia yang mengalami masalah pemenuhan kebutuhan dasarnya akibat gangguan salah satu sistem (organ) ataupun beberapa sistem (organ) tubuhnya dalam keadaan gawat darurat.

Praktik Klinik Keperawatan Kritis mencakup asuhan keperawatan pada klien dengan berbagai tingkat usia di unit perawatan kritis yang mengalami gangguan sistem kardiovaskuler, pernafasan, persarafan, pencernaan, perkemihan, infeksi dan kondisi khusus.

2. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Capaian Pembelajaran Praktik Klinik Keperawatan Gawatdarurat

Setelah mengikuti praktik klinik keperawatan gawat darurat mahasiswa mampu :

1. Melakukan komunikasi yang efektif dalam pemberian asuhan keperawatan pada klien dengan berbagai tingkat usia dalam keadaan gawat darurat.
2. Menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dalam kerja tim.
3. Menggunakan teknologi dan informasi kesehatan secara efektif dan bertanggung jawab.
4. Menggunakan proses keperawatan dalam menyelesaikan masalah klien pada berbagai tingkat usia dalam keadaan gawat darurat akibat gangguan:
 - Termoregulasi : trauma kapitis.
 - Oksigenasi : Infark Miokard, Gagal nafas, trauma thoraks
 - Pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit : DM dengan ketoasidosis, krisis tiroid.
 - Keamanan fisik : keracunan, sengatan binatang berbisa.
5. Menggunakan langkah-langkah pengambilan keputusan etis dan legal pada klien dengan berbagai tingkat usia dalam keadaan gawat darurat.
6. Mengkolaborasikan berbagai aspek dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan klien dengan berbagai tingkat usia dalam keadaan gawat darurat.
7. Mendemonstrasikan keterampilan teknis keperawatan yang sesuai dengan standar yang berlaku atau secara kreatif dan inovatif agar pelayanan yang diberikan efisien dan efektif pada klien dengan berbagai tingkat usia dalam keadaan gawat darurat: resusitasi/RJP/BHD.
8. Mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis dalam mengembangkan asuhan keperawatan pada klien dengan berbagai tingkat usia dalam keadaan gawat darurat (Triage).
9. Menjalankan fungsi advokasi pada klien dengan berbagai tingkat usia dalam keadaan gawat darurat untuk mempertahankan hak klien agar dapat mengambil keputusan untuk dirinya.

10. Mempertahankan lingkungan yang aman secara konsisten melalui penggunaan strategi manajemen kualitas dan manajemen risiko pada klien dengan berbagai tingkat usia dalam keadaan gawat darurat.
11. Melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dalam bidang kesehatan.
12. Memberikan dukungan kepada tim asuhan dengan mempertahankan akuntabilitas asuhan keperawatan yang diberikan .
13. Mewujudkan lingkungan bekerja yang kondusif.
14. Mengembangkan potensi diri untuk meningkatkan kemampuan profesional
15. Berkontribusi dalam mengembangkan profesi keperawatan.
16. Menggunakan hasil penelitian untuk diterapkan dalam pemberian asuhan keperawatan.

Capaian Pembelajaran Praktik Klinik Keperawatan Kritis

Setelah mengikuti praktik klinik keperawatan kritis mahasiswa mampu :

1. Melakukan komunikasi yang efektif dalam pemberian asuhan keperawatan pada klien dengan berbagai tingkat usia di unit perawatan kritis yang mengalami gangguan sistem kardiovaskuler, pernafasan, persarafan, pencernaan, perkemihan, infeksi dan kondisi khusus.
2. Menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dalam kerja tim.
3. Menggunakan teknologi dan informasi kesehatan secara efektif dan bertanggung jawab.
4. Menggunakan proses keperawatan dalam menyelesaikan masalah klien dengan berbagai tingkat usia di unit perawatan kritis yang mengalami gangguan sistem kardiovaskuler pernafasan, persarafan, pencernaan, perkemihan dan endokrin, infeksi dan kondisi khusus:
5. Menggunakan langkah-langkah pengambilan keputusan etis dan legal pada klien dengan berbagai tingkat usia di unit perawatan kritis yang mengalami gangguan sistem kardiovaskuler pernafasan, persarafan, pencernaan, perkemihan dan endokrin, infeksi dan kondisi khusus.
6. Mengkolaborasikan berbagai aspek dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan klien dengan berbagai tingkat usia di unit perawatan kritis yang mengalami gangguan sistem kardiovaskuler pernafasan, persarafan, pencernaan, perkemihan dan endokrin, infeksi dan kondisi khusus.
7. Mendemonstrasikan keterampilan teknis keperawatan yang sesuai dengan standar yang berlaku atau secara kreatif dan inovatif agar pelayanan yang diberikan efisien dan efektif pada klien dengan berbagai tingkat usia di unit perawatan kritis yang mengalami gangguan sistem kardiovaskuler pernafasan, persarafan, pencernaan, perkemihan dan endokrin, infeksi dan kondisi khusus: Monitoring hemodinamik, ventilator mekanik, Suction oro/endotrakheal.
8. Mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis dalam mengembangkan asuhan keperawatan pada klien dewasa, anak dan neonatus di unit perawatan kritis yang mengalami gangguan sistem kardiovaskuler pernafasan, persarafan, pencernaan, perkemihan dan endokrin, infeksi dan kondisi khusus.
9. Menjalankan fungsi advokasi pada klien dewasa, anak dan neonatus di unit perawatan kritis yang mengalami gangguan sistem kardiovaskuler pernafasan, persarafan, pencernaan, perkemihan dan endokrin, infeksi dan kondisi khusus untuk mempertahankan hak klien agar dapat mengambil keputusan untuk dirinya.
10. Mempertahankan lingkungan yang aman secara konsisten melalui penggunaan strategi manajemen kualitas dan manajemen risiko pada klien dewasa, anak dan neonatus di unit perawatan kritis yang mengalami gangguan sistem kardiovaskuler pernafasan, persarafan, pencernaan, perkemihan dan endokrin, infeksi dan kondisi khusus.

11. Melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dalam bidang kesehatan .
12. Memberikan dukungan kepada tim asuhan dengan mempertahankan akontabilitas asuhan keperawatan yang diberikan .
13. Mewujudkan lingkungan bekerja yang kondusif.
14. Mengembangkan potensi diri untuk meningkatkan kemampuan professional
15. Berkontribusi dalam mengembangkan profesi keperawatan.
16. Menggunakan hasil penelitian untuk diterapkan dalam pemberian asuhan keperawatan.

3. PELAKSANAAN PRAKTEK KEPERAWATAN

- a. Bobot SKS dan Jumlah Waktu yang Dibutuhkan
Praktek Klinik Keperawatan Gawatdarurat dan Kritis mempunyai beban studi 2 SKS sehingga waktu yang dibutuhkan total adalah 2 minggu.
- b. Tempat Praktek
Praktek Keperawatan akan dilaksanakan di RS Prima Husada Sukorejo
- c. Pelaksanaan Praktek Klinik Keperawatan Gawatdarurat dan Kritis
Kegiatan Praktek Klinik Keperawatan Gawatdarurat dan Kritis di RS Prima Husada Sukorejo akan dilaksanakan selama 2 minggu, 20 April – 02 Mei 2026 (jadwal terlampir).

4. URAIAN TUGAS

- a. Tugas Perorangan di Klinik/Rumah Sakit
 - Membuat Laporan Pendahuluan sebelum menyusun Asuhan Keperawatan sesuai dengan kasus pada Pasien yang akan diasuhinya.
 - Melaksanakan Asuhan Keperawatan pada Klien sesuai dengan Kompetensi Mata Ajar (Bidang Keperawatan) dan menyusun Laporan Asuhan Keperawatan.
 - Melaksanakan Tindakan Keperawatan sesuai dengan perencanaan dan mengisi Pedoman Penilaian sesuai dengan tindakan yang dilakukan yang ditanda tangani/diketahui oleh Preceptor.
 - Mengikuti Responsi Asuhan Keperawatan.
 - Melaksanakan Evaluasi Akhir Praktek Klinik Keperawatan berupa ujian di akhir Rotasi Praktek.
 - Mengisi Daftar Hadir/Presensi yang diketahui oleh Pembimbing Lahan.
- b. Tugas Kelompok
 - Melaksanakan kegiatan Pra Interaksi dengan melihat kasus yang akan diambil di masing-masing ruangan satu hari sebelum pelaksanaan praktek.
 - Mengikuti Orientasi di setiap Ruangan sehari sebelum hari pertama dinas di Ruangan.
 - Mengikuti *Pre* dan *Post Conference* di setiap Ruangan.
 - Melaksanakan seminar kasus di minggu terakhir putaran praktek profesi KMB.

5. PESERTA

Peserta adalah Mahasiswa Semester VIII Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Malang Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Malang sejumlah 1 orang yang terbagi dalam 1 Kelompok (1 Kelompok terdiri dari 1 Mahasiswa)

6. PRECEPTOR

Preceptor terdiri dari Preceptor Akademik, yaitu kelompok dosen yang mengampu Mata Kuliah di Departemen yang bersangkutan dan Preceptor Klinik, yaitu Perawat yang ditunjuk sebagai Preceptor termasuk perawat jaga.

a. Tugas Preceptor Klinik Rumah Sakit

- Membimbing Orientasi Mahasiswa sehari sebelum Praktek atau sesuai kesepakatan.
- Menentukan kasus Pasien yang akan dikelola Mahasiswa dan dijadikan bahan Laporan.
- Memeriksa Laporan Pendahuluan Mahasiswa.
- Membimbing *Pre* dan *Post Conference*.
- Membimbing, mengarahkan Mahasiswa pada saat proses Asuhan Keperawatan.
- Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Tindakan Keperawatan.
- Memberikan tanda tangan pada Buku Kehadiran/Presensi Mahasiswa.
- Bersama-sama Pembimbing Institusi dalam melaksanakan Evaluasi Akhir Rotasi Departemen.
- Memberikan penilaian Sikap sesuai dengan yang terdapat dalam Buku Pedoman.
- Mencatat dan menginformasikan permasalahan Mahasiswa selama Praktek di Ruang.

b. Tugas Preceptor Akademik

- Melakukan Responsi Laporan Pendahuluan dan Responsi Asuhan Keperawatan.
- Membimbing dan mengarahkan Mahasiswa pada proses Asuhan Keperawatan.
- Memberikan penilaian Responsi.
- Bersama Pembimbing Lahan melakukan Evaluasi Akhir Departemen berupa ujian.
- Memberikan penilaian Sikap sesuai dengan yang terdapat dalam Buku Pedoman.
- Memfasilitasi mahasiswa dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kegiatan Praktek.
- Memberikan Ijin kepada Mahasiswa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Masuk yang dibuat Mahasiswa atau dibuat oleh Dokter.

7. EVALUASI

Evaluasi berdasarkan tugas yang dibebankan kepada Mahasiswa, yaitu:

1. Laporan pendahuluan	Bobot : 10 %
2. Laporan asuhan keperawatan	Bobot : 20 %
3. Tindakan atau prosedur perawatan	Bobot : 30 %
4. Penyuluhan	Bobot : 10 %
5. Sikap selama Praktik berlangsung	Bobot : 20 %
6. Seminar	Bobot : 10%

Rentang nilai yang digunakan:

Angka Absolut	Angka Mutu	Huruf Mutu
80–100	4,00	A
75–79	3,70	A-
72–74	3,30	B+
68–71	3,00	B
64–67	2,70	B-
61–63	2,30	C+
58–60	2,00	C
52–57	1,70	C-
41–51	1,00	D
0–40	0,00	E

8. Jadwal

Jadwal Praktek Profesi Keperawatan terlampir.

Malang, Februari 2026

a.n. Plt. Direktur
Ketua Jurusan Keperawatan



Dr. Erlina Suci Astuti, S.Kep.Ns., M.Kep

PROPOSAL

**PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN PALIATIF
PRODI SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN MALANG
JURUSAN KEPERAWATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG
SEMESTER VIII TAHUN AKADEMIK 2025/2026 (KELAS RPL)**



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN MALANG
JURUSAN KEPERAWATAN
TAHUN 2026**

**PROPOSAL PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN PALIATIF
PRODI SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN MALANG
JURUSAN KEPERAWATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG
SEMESTER VIII TAHUN AKADEMIK 2025/2026 (KELAS RPL)**

1. DISKRIPSI

Praktek Klinik Keperawatan Paliatif merupakan praktek keperawatan pada seorang pasien dan keluarganya yang memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan cara memaksimalkan kualitas hidup pasien serta mengurangi gejala yang mengganggu, mengurangi nyeri dengan memperhatikan aspek psikologis dan spiritual.

Perawatan paliatif memberikan pendekatan kesehatan terpadu yang bersifat aktif dan menyeluruh, yaitu pendekatan multidisiplin yang terintegrasi. Adapun latar belakang diperlukannya Praktik Klinik Keperawatan Paliatif adalah karena meningkatnya jumlah pasien dengan penyakit yang belum dapat disembuhkan (baik pada dewasa maupun anak), seperti penyakit kanker, penyakit paru obstruktif kronis, stroke, parkinson, gagal jantung, gagal ginjal terminal, dan lain-lain.

Praktek keperawatan ini merupakan bagian dari rangkaian proses pendidikan keperawatan yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Malang di Pendidikan Tinggi Keperawatan. Praktek Klinik ini dijalankan agar mahasiswa dapat mengaplikasikan secara nyata kepada pasien di lingkungan keperawatan paliatif yang mencakup berbagai *evidence based practice* dalam keperawatan paliatif, prinsip komunikasi dalam keperawatan paliatif, dan memahami berbagai masalah klien paliatif baik bio-psiko-sosial-kultural-spiritual hingga memasuki masa menjelang ajal.

Setelah menjalankan program ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan asuhan keperawatan pada pasien *terminal illness* dengan berbagai masalah klien paliatif baik bio-psiko-sosial-kultural-spiritual hingga memasuki masa menjelang ajal. Mahasiswa juga diharapkan menentukan diagnosis keperawatan yang terjadi pada klien dan melaksanakan tindakan-tindakan dasar keperawatan paliatif untuk memenuhi kebutuhan klien dan keluarga.

Keterampilan dasar keperawatan paliatif difokuskan untuk mengasah kemampuan mahasiswa agar mampu bersikap dan bertindak sebagai perawat profesional. Kemampuan yang dimaksud adalah mampu mengaplikasikan prinsip komunikasi dalam keperawatan paliatif, mampu memahami patofisiologi penyakit kronik dan terminal, mampu melakukan asuhan pasien penyakit terminal, mampu mengaplikasikan prinsip dasar tinjauan agama dan sosial budaya dalam keperawatan paliatif, bersikap *caring* di setiap kesempatan memberikan asuhan keperawatan, membina hubungan interpersonal kepada klien dan keluarganya, memberikan asuhan saat klien dan keluarga mengalami gangguan fisik dan emosional. Proses pembelajaran memberikan pengalaman Praktek Klinik Keperawatan Paliatif di Rumah Sakit dengan metode yang digunakan dalam pembelajaran praktek adalah kombinasi dari *Conference*, *Bed Side Teaching*, dan *Case Discussion/Case Conference*.

2. CAPAIAN PEMBELAJARAN PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN PALIATIF

Pada akhir Mata Kuliah, mahasiswa diharapkan mampu menentukan gangguan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual hingga memasuki masa menjelang ajal yang terjadi pada klien dan melaksanakan tindakan-tindakan dasar keperawatan paliatif untuk memenuhi kebutuhan klien dan keluarga. Mahasiswa juga diharapkan mampu menggunakan pendekatan proses keperawatan sebagai dasar analisis kegiatan yang dilakukan di setiap tindakan.

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN PALIATIF

1. Menyusun rencana asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi keperawatan serta dapat melakukan perencanaan pulang yang adekuat
 - a. Menegakkan diagnosa keperawatan yang terkait dengan gangguan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual hingga memasuki masa menjelang ajal klien.
 - b. Menjelaskan rasional diagnosa dan tindakan keperawatan untuk mengatasi gangguan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual hingga memasuki masa menjelang ajal.
2. Menggunakan proses keperawatan dalam menyelesaikan masalah klien pada berbagai tingkat usia dalam keadaan paliatif pada diagnosa medis:
 - a. Penyakit kanker.
 - b. Gagal jantung.
 - c. Penyakit paru obstruktif kronis (PPOK).
 - d. Gagal ginjal terminal / ESRD.
 - e. Stroke.
 - f. HIV/AIDS.
 - g. Parkinson, dan lain-lain.
3. Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan profesional dalam:
 - a. Menunjukkan sikap *caring* di setiap asuhan keperawatan paliatif yang diberikan.
 - b. Menerapkan tindakan *universal precaution* di setiap asuhan keperawatan paliatif yang diberikan.
 - c. Membina komunikasi terapeutik dalam perawatan paliatif dengan klien dan keluarga.
 - d. Melakukan tindakan keperawatan untuk mengatasi kecemasan.
 - e. Melakukan tindakan keperawatan untuk mengatasi gangguan konsep diri.
 - f. Melakukan tindakan keperawatan untuk mengatasi kehilangan dan berduka.
 - g. Melakukan tindakan keperawatan untuk memenuhi kebutuhan spiritual.
 - h. Memberikan pendidikan kesehatan dan perencanaan pulang untuk klien dan keluarga.
 - i. Melakukan pemeriksaan fisik umum (*general survey*).
 - j. Melakukan pemeriksaan psikologis (fase pengingkaran, fase marah, fase tawar menawar, fase depresi, dan fase penerimaan).
 - k. Melakukan pengkajian nyeri meliputi provocation, Quality, Region/Radiation, Scale/severity, Time.
 - l. Melakukan pengukuran nyeri menggunakan metode: numeric rating scale/NRS, Visual Analog Scale/VAS, Wong-Baker Pain Rating Scale, dll.
 - m. Melakukan manajemen nyeri.
 - n. Melakukan berbagai terapi komplementer: nafas dalam, disistraksi dan relaksasi, terapi tusik, aromaterapi, massage, cognitive behavioral therapy, guided imagery, dll.
 - o. Berkolaborasi dalam pemberian obat sedasi
 - p. Berkolaborasi dalam pemberian obat analgesik: analgesik tingkat ringan, sedang, tinggi.

- q. Kolaborasi pemberian obat kemoterapi paliatif
- r. Perawatan luka pasca pembedahan paliatif
- s. Kolaborasi radioterapi paliatif
- t. Kolaborasi penggunaan anti retroviral
- u. Melakukan perawatan personal hygiene antara lain perawatan mulut, perawatan kaki dan kuku, perawatan rambut, perawatan mata, hidung dan telinga.
- v. Melakukan perawatan kulit untuk meminimalkan paparan terhadap iritan, yaitu: pemberian lotion supaya tidak kering, pengaturan posisi tidur, penggantian linen dan penataan linen dengan rapi
- w. Memberikan posisi yang meningkatkan pola napas
- x. Memberikan terapi oksigen
- y. Pemenuhan kebutuhan nutrisi: memasang dan melepaskan nasogastric tube, Memberikan makan melalui NGT/Oral, dll.
- z. Pemenuhan kebutuhan cairan
- aa. Melakukan kanulasi intra vena: pasang, rawat, lepas.
- bb. Memberikan terapi cairan infus.
- cc. Memasang dan merawat kateter urin.
- dd. memberikan medikasi melalui intramuskular, intravena, subkutan, dan intrakutan.
- ee. Membantu dalam ambulasi/mobilisasi.
- ff. Melakukan pembatasan pengunjung yang menyebabkan pasien letih.

4. PELAKSANAAN PRAKTEK KEPERAWATAN

- a. Bobot SKS dan Jumlah Waktu yang Dibutuhkan
Praktek Klinik Keperawatan Paliatif mempunyai beban studi 1 SKS sehingga waktu yang dibutuhkan total adalah 1 minggu.
- b. Tempat Praktek
Praktek Keperawatan akan dilaksanakan di RS Prima Husada Sukorejo
- c. Pelaksanaan Praktek Klinik Keperawatan Paliatif
Kegiatan Praktek Klinik Keperawatan Paliatif RS Prima Husada Sukorejo dilaksanakan selama 1 minggu, yaitu mulai tanggal 04 – 09 Mei 2026.

5. URAIAN TUGAS

a. Tugas Perorangan di Klinik/Rumah Sakit

- 1) Membuat Laporan Pendahuluan sebelum menyusun Asuhan Keperawatan sesuai dengan kasus pada Pasien yang akan diasuhinya.
- 2) Melaksanakan Asuhan Keperawatan pada Klien sesuai dengan Kompetensi Mata Ajar (Bidang Keperawatan) dan menyusun Laporan Asuhan Keperawatan.
- 3) Melaksanakan Tindakan Keperawatan sesuai dengan perencanaan dan mengisi Pedoman Penilaian sesuai dengan tindakan yang dilakukan yang ditanda tangani/diketahui oleh Pembimbing.
- 4) Mengikuti Responsi Asuhan Keperawatan.
- 5) Mengisi Daftar Hadir/Presensi yang diketahui oleh Pembimbing Lahan.

b. Tugas Kelompok

- 1) Melaksanakan kegiatan Pra Interaksi dengan melihat kasus yang akan diambil di masing-masing ruangan satu hari sebelum pelaksanaan praktek.
- 2) Mengikuti Orientasi di setiap Ruangan sehari sebelum hari pertama dinas di Ruangan.
- 3) Mengikuti *Pre* dan *Post Conference* di setiap Ruangan.

6. PESERTA

Peserta adalah Mahasiswa Semester VIII Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Malang Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Malang sejumlah 1 orang yang terbagi dalam 1 Kelompok (1 Kelompok terdiri dari 1 Mahasiswa).

7. PEMBIMBING

Pembimbing terdiri dari Pembimbing Institusi, yaitu kelompok dosen yang mengampu Mata Kuliah di Departemen yang bersangkutan dan Pembimbing Klinik, yaitu Perawat yang ditunjuk sebagai Pembimbing termasuk perawat jaga.

a. Tugas Pembimbing Klinik Rumah Sakit

- 1) Membimbing Orientasi Mahasiswa sehari sebelum Praktek atau sesuai kesepakatan.
- 2) Menentukan kasus Pasien yang akan dikelola Mahasiswa dan dijadikan bahan Laporan.
- 3) Memeriksa Laporan Pendahuluan Mahasiswa.
- 4) Membimbing *Pre* dan *Post Conference*.
- 5) Membimbing, mengarahkan Mahasiswa pada saat proses Asuhan Keperawatan.
- 6) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Tindakan Keperawatan.
- 7) Memberikan tanda tangan pada Buku Kehadiran/Presensi Mahasiswa.
- 8) Memberikan penilaian Sikap sesuai dengan yang terdapat dalam Buku Pedoman.
- 9) Mencatat dan menginformasikan permasalahan Mahasiswa selama Praktek di Ruangan.

b. Tugas Pembimbing Institusi Pendidikan

- 1) Melakukan Responsi Laporan Pendahuluan dan Responsi Asuhan Keperawatan.
- 2) Membimbing dan mengarahkan Mahasiswa pada proses Asuhan Keperawatan.
- 3) Memberikan penilaian Responsi.
- 4) Memberikan penilaian Sikap sesuai dengan yang terdapat dalam Buku Pedoman.
- 5) Memfasilitasi mahasiswa dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kegiatan Praktek.
- 6) Memberikan Ijin kepada Mahasiswa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Masuk yang dibuat Mahasiswa atau dibuat oleh Dokter.

8. EVALUASI

Evaluasi berdasarkan tugas yang dibebankan kepada Mahasiswa, yaitu:

- a. Setiap Mahasiswa membuat Laporan Asuhan Keperawatan selama waktu praktek dengan Bobot Penilaian 40%.
- b. Melakukan Prosedur Tindakan sesuai dengan target yang terdapat dalam Buku Pedoman dengan Bobot Penilaian 40%.
- c. Sikap (Etiket) dan Kehadiran dengan Bobot Penilaian 20%.

d. Rentang nilai yang digunakan:

Angka Absolut	Angka Mutu	Huruf Mutu
80–100	4,00	A
75–79	3,70	A-
72–74	3,30	B+
68–71	3,00	B
64–67	2,70	B-
61–63	2,30	C+
58–60	2,00	C
52–57	1,70	C-
41–51	1,00	D
0–40	0,00	E

Malang, Februari 2026

a.n. Plt. Direktur
Ketua Jurusan Keperawatan



Dr. Erlina Suci Astuti, S.Kep.Ns., M.Kep

PROPOSAL
PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN PERIOPERATIF
PRODI SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN MALANG
SEMESTER VIII TAHUN AKADEMIK 2025/2026 (KELAS RPL)



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG
JURUSAN KEPERAWATAN
TAHUN 2026

PROPOSAL
PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN PERIOPERATIF
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN MALANG
JURUSAN KEPERAWATAN POLTEKKES KEMENKES MALANG
TAHUN AKADEMIK 2025/2026 (KELAS RPL)

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Struktur Program Sarjana Terapan Keperawatan Malang minat Perioperatif Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, mahasiswa dalam Semester VIII diharapkan memperoleh pengalaman belajar klinik lanjutan di bidang keperawatan perioperatif di Rumah Sakit.

Praktek Klinik Keperawatan bidang Perioperatif adalah kegiatan praktek mahasiswa di tatanan nyata pelayanan kesehatan dimana mahasiswa menangani masalah kesehatan pada kasus kasus bedah sebelum, selama dan setelah operasi.

Dalam pembelajaran klinik, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan kognitif, psikomotor dan sikap (attitude), juga diharapkan mampu bekerjasama dengan sesama anggota profesi keperawatan dan antar profesi kesehatan lainnya.

II. TUJUAN

1. Umum

Setelah menyelesaikan pengalaman belajar praktek klinik keperawatan, mahasiswa diharapkan mampu melakukan asuhan keperawatan sebelum, selama dan sesudah operasi berdasarkan konsep dasar ilmiah keperawatan dan mengaplikasikan prinsip berfikir dan bersikap kritis dan etis.

2. Khusus

Pada akhir proses pengalaman belajar klinik, mahasiswa mampu:

- a. Melakukan pengkajian keperawatan komprehensif (riwayat kesehatan, pengkajian fisik–psikologis, penelaahan pemeriksaan diagnostik) pada kasus klien yang mengalami gangguan sistem tubuh di area pre operasi, intra operasi, dan post operasi (ruang pemulihan)
- b. Melakukan analisa data hasil pengkajian dan merumuskan masalah keperawatan pada klien yang mengalami gangguan sistem tubuh di area pre operasi, intra operasi, dan post operasi (ruang pemulihan)
- c. Menyusun intervensi keperawatan sesuai masalah keperawatan pada klien yang mengalami gangguan sistem tubuh di area pre operasi, intra operasi dan post operasi (ruang pemulihan)
- d. Melakukan implementasi keperawatan (mandiri dan kolaborasi) untuk memecahkan masalah keperawatan pada klien yang akan menjalani tindakan pembedahan, yaitu:
 - Memasang kateter urine
 - Merekam dan menganalisa ECG
 - Memberikan oksigen
 - Mengambil darah vena
 - Memasang iv line
 - Memasang NGT
 - Mengajari pasien manajemen nyeri
 - Melakukan pendidikan preoperatif
 - Melakukan persiapan pasien sebelum menjalani pembedahan
 - Melakukan transport pasien keruang prabedah

- e. Melakukan tindakan keperawatan klien (pre operasi), meliputi:
- Melakukan *General Precaution* (scrubbing, gowning, gloving)
 - Melakukan penataan kamar bedah
 - Melakukan persiapan alat hemostat, tourniquet, dan electrosurgical, serta bahan habis pakai pembedahan.
 - Meminimalkan terjadinya infeksi nosokomial dikamar operasi
 - Memfasilitasi pemberian cairan, obat-obatan dan alkes sesuai tindakan operasi
 - Melakukan sterilisasi dan desinfeksi kamar bedah, pencucian, pengepakan dan penyimpanan
 - Melakukan transfer pasien ke meja mayo
 - Memberikan posisi bedah
 - Mengidentifikasi kelengkapan data dan kondisi pasien pre operasi
 - Menyiapkan pasien memasuki area semi ketat/ruang induksi
 - Melaksanakan persiapan personal sebelum melakukan tindakan operasi
 - Melaksanakan persiapan klien yang akan dilakukan tindakan operasi
 - Menyiapkan instrument sesuai dengan kebutuhan sebelum tindakan operasi
- f. Melakukan tindakan keperawatan klien (intra operasi), meliputi
- Melakukan asuhan keperawatan perioperatif pada bedah orthopedi, digestif, onkologi, saraf, obgyn, dan TKV
 - Melakukan setting dan handling instrumen pada bedah ortopedi selama operasi berlangsung
 - Melakukan setting dan handling instrumen pada bedah digestif selama operasi berlangsung
 - Melakukan setting dan handling instrumen pada pasien bedah onkologi selama operasi berlangsung
 - Melakukan setting dan handling instrumen pada bedah saraf selama operasi berlangsung
 - Melakukan setting dan handling instrumen pada bedah Obgyn selama operasi berlangsung
 - Melakukan setting dan handling instrumen pada bedah TKV selama operasi berlangsung
 - Melakukan handling instrument selama operasi berlangsung
 - Melakukan drapping
 - Membantu proses *wound closure*
 - Merawat instrument
- g. Melakukan tindakan keperawatan klien (Post operasi), meliputi:
- Melakukan pemeriksaan airway, breathing dan sirkulasi
 - Melakukan pembebasan jalan napas
 - Memberikan terapi oksigen sesuai kebutuhan pasien
 - Memantau jumlah perdarahan pasca operasi
 - Memantau keseimbangan cairan dan elektrolit
 - Memberikan terapi cairan sesuai kondisi pasien
 - Memantau heart monitor dan elektrokardiogram
 - Memantau drainage cairan melalui selang
 - Memantau status kesadaran
 - Mampu mengelola nyeri pada pasien pasca operasi
 - Mengobservasi kondisi pembalut luka

- h. Melakukan evaluasi keperawatan pada klien yang mengalami gangguan sistem tubuh di area pre operasi (Bedah), intra operasi dan post operasi (ruang pemulihan)

III. PELAKSANAAN PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN

1. Lama Praktek

Praktek Klinik Keperawatan akan dilaksanakan selama 4 minggu dimulai tanggal 11 Mei – 06 Juni 2026 (jadwal terlampir).

2. Tempat Praktek

Praktek Klinik Keperawatan akan dilaksanakan di RS Prima Husada Sukorejo

IV. PEMBIMBING

Pembimbing Praktek Klinik berasal dari Dosen Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Malang Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Malang dan pembimbing dari wahana praktek sesuai dengan penunjukan.

1. Tugas Pembimbing Klinik Rumah Sakit

- a. Melakukan orientasi bersama mahasiswa
- b. Menentukan kasus pasien yang akan dikelola mahasiswa
- c. Memeriksa Laporan Pendahuluan mahasiswa
- d. Melakukan Pre dan Post Conference
- e. Membimbing, mengarahkan mahasiswa pada proses asuhan keperawatan
- f. Mengikuti presentasi makalah kelompok
- g. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Tindakan Keperawatan
- h. Menandatangani Presensi Mahasiswa
- i. Memeriksa dan menandatangani Laporan Kegiatan Harian Mahasiswa
- j. Mencatat dan menginformasikan permasalahan mahasiswa selama praktek di Ruang

2. Tugas Pembimbing Klinik Institusi Pendidikan

- a. Melakukan responsi Laporan Pendahuluan dan Responsi Asuhan Keperawatan
- b. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa pada proses Asuhan Keperawatan
- c. Memberikan penilaian Responsi dan Seminar Asuhan Keperawatan

V. JUMLAH MAHASISWA

Mahasiswa Praktek Klinik Keperawatan Perioperatif sebanyak 1 orang mahasiswa terbagi dalam 1 kelompok

URAIAN TUGAS MAHASISWA

1. Tugas Perorangan

- a. Membuat Laporan Pendahuluan sebelum menyusun Asuhan Keperawatan pada masing-masing Ruang.
- b. Melaksanakan Asuhan Keperawatan pada klien sesuai dengan kompetensi mata ajar (bidang keperawatan) dan menyusun Laporan Asuhan Keperawatan.
- c. Membuat laporan instrumen teknik pembedahan sesuai dengan kompetensi.
- d. Melaksanakan Tindakan Keperawatan sesuai dengan perencanaan terhadap masalah kesehatan yang terjadi, yang ditandatangani/diketahui oleh Pembimbing.
- e. Mengikuti Responsi Asuhan Keperawatan
- f. Melaksanakan Ujian Praktek Klinik pada akhir praktek
- g. Presentasi di Ruang yang bersangkutan (**HARUS 100%**)

2. Tugas Kelompok

- a. Melaksanakan kegiatan pra interaksi dengan melihat kasus yang akan diambil di masing-masing ruangan satu hari sebelum pelaksanaan praktek

- b. Mengikuti orientasi di setiap ruangan sehari sebelum hari pertama dinas di ruangan
- c. Bertanggung jawab dalam melaksanakan Asuhan Keperawatan terhadap seluruh klien yang ada di setiap ruangan dengan pengawasan pembimbing melalui metode penugasan team
- d. Mengikuti pre dan post conference di setiap ruangan

VI. EVALUASI

Nilai Praktek Klinik Keperawatan, untuk masing-masing sistem terdiri atas:

- a. Nilai Responsi Laporan Pendahuluan : bobot 20%
- b. Nilai Laporan Askep dan Responsi Asuhan Keperawatan : bobot 30%
- c. Tindakan Keperawatan : bobot 30%
- d. Nilai Sikap : bobot 20%

Rentang Nilai Praktek Keperawatan:

- A : 81-100
- A- : 75-79
- B+ : 72-74
- B : 68-71
- B- : 64-67
- C+ : 61-63
- C : 58-60
- C- : 52-57
- D : 41-51
- E : 0-40

VII. TATA TERTIB PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN

1. Ketentuan Pakaian Seragam di Rumah Sakit

- a. Memakai seragam dinas rumah sakit yang telah ditentukan, yaitu blouse biru telur asin dan bawahan (celana panjang) dengan warna senada.
- b. Memakai sepatu hitam yang rapi.
- c. Tidak menggunakan asesoris yang dapat berisiko sebagai media infeksi nosokomial.
- d. Bagi yang berkerudung, menggunakan kerudung yang rapi dan tidak mengganggu dalam melaksanakan tugas di wahana sesuai ketentuan.
- e. Bagi yang tidak berkerudung, diwajibkan menggunakan penutup kepala (Kap kepala) yang rapi dan menutup rambut.
- f. Bagi mahasiswa pria tidak diperkenankan berambut gondrong, bertato, berjambang, berjenggot yang berlebihan serta beraksesoris yang dapat berisiko infeksi nosokomial.
- g. Menggunakan papan nama yang terdapat foto diri mahasiswa.
- h. Menggunakan skort/jas lab sesuai ketentuan (bila diperlukan).

2. Ketentuan Presensi

Jumlah kehadiran Praktek Klinik Keperawatan adalah 100%.

- Sakit : harus ada Surat Keterangan Sakit dari Dokter
- Ijin : harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Koordinator Praktek Klinik Keperawatan minimal 1 hari sebelum pelaksanaan
- Tanpa Keterangan

3. Ketentuan Lain

- a. Mahasiswa harus sudah memprogram Mata Kuliah Praktek Klinik Keperawatan pada Semester yang bersangkutan dengan sepengetahuan Pembimbing Akademik (PA)
- b. Mahasiswa harus berada di lokasi/Ruangan kegiatan Praktek Klinik dan Laboratorium Keperawatan.
 - Pagi : pukul 07.00–14.00 WIB
 - Siang : pukul 14.00–21.00 WIB
 - Malam : pukul 21.00–07.00 WIB
- c. Apabila akan meninggalkan Ruangan Praktek, harus seijin Kepala Ruangan/Pembimbing atau Perawat Kepala Jaga (bila dinas sore pada hari besar)
- d. Mahasiswa wajib memenuhi aturan atau ketentuan yang berlaku pada Institusi Pendidikan dan Rumah Sakit/wahana praktek yang ditempati
- e. Mahasiswa wajib mengisi presensi (hadir/pulang) setiap mengikuti kegiatan Praktek Klinik dan dimintakan tanda tangan Kepala Ruang atau Perawat Kepala Jaga
- f. Mahasiswa harus bertanggung jawab atas keutuhan/kelengkapan peralatan Institusi Pendidikan dan Rumah Sakit/wahana praktek yang ditempati
- g. Hasil penilaian Kegiatan Praktek Klinik Keperawatan (Buku Check Lyst) harus ditandatangani oleh Pembimbing Praktek atau Perawat Kepala Jaga yang diberi wewenang oleh Pembimbing Ruangan

4. Kategori Tingkat Pelanggaran

- a. Pelanggaran Ringan
 - Tidak memakai salah satu ketentuan seragam (lencana, papan nama, sepatu, cap)
 - Menggunakan perhiasan diluar ketentuan
 - Berhias berlebihan atau memakai cat kuku
- b. Pelanggaran Sedang
 - Mengulangi satu atau lebih item pelanggaran ringan
 - Kedapatan/ketahuan memalsu tanda tangan teman
 - Merusak alat Institusi Pendidikan, Rumah Sakit tanpa sengaja atau akibat kelalaian
 - Meninggalkan Ruangan tanpa sepengetahuan Pembimbing Praktek Rumah Sakit
 - Melanggar Tata Tertib atau Peraturan Rumah Sakit yang berlaku
 - Tidak sopan terhadap sesama Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit
 - Mengabaikan teguran Pembimbing
 - Melakukan hal-hal yang lain yang kurang berkenan atau hal yang tidak sesuai dengan norma
- c. Pelanggaran Berat
 - Kedapatan memalsu nilai atau tanda tangan Dosen, Pembimbing Ruangan dan Perawat Kepala Jaga
 - Tidak mengikuti kegiatan Praktek tanpa keterangan
 - Mengulangi satu atau lebih item pelanggaran sedang
 - Melakukan tindakan yang berakibat fatal bagi pasien

5. Sanksi

- a. Pelanggaran Ringan dengan sanksi:
 - Teguran lisan
 - Membuat pernyataan diketahui Koordinator Praktek Klinik dan Laboratorium Keperawatan dan disampaikan kepada orangtua mahasiswa yang bersangkutan
 - Kedua sanksi di atas dilakukan secara bersama-sama

- b. Pelanggaran Sedang dengan sanksi:
- Membuat pernyataan diketahui Ketua Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan dan disampaikan kepada orangtua mahasiswa yang bersangkutan
 - Memperoleh penugasan akademik
 - Bila merusak/menghilangkan peralatan milik Rumah Sakit/Institusi Pendidikan, harus mengganti alat yang bersangkutan
- c. Pelanggaran Berat dengan sanksi:
- Membuat pernyataan diketahui oleh Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Malang dan orangtua, wali kelas serta dipanggil ke Pendidikan
 - Mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat karena ketidak hadirannya tanpa keterangan dinyatakan tidak lulus Praktek Klinik Keperawatan pada bagian yang ditinggalkan (Mata Kuliah), sehingga harus mengulang Mata Kuliah tersebut tahun berikutnya
 - Mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat karena melakukan tindakan yang berakibat fatal bagi pasien, diberhentikan sementara atau dikeluarkan dari Pendidikan
 - Sanksi satu dan dua dilaksanakan bersama-sama, sedangkan sanksi tiga dilaksanakan sendiri

6. Sanksi terhadap Ketidak Hadiran Praktek

- a. Ketidak hadirannya Praktek Klinik Keperawatan karena sakit atau ijin kurang dari 10% dari jumlah kehadiran yang seharusnya di masing-masing bagian/bidang keperawatan, harus mengganti praktek sejumlah hari yang ditinggalkan dengan ijin dari Koordinator Praktek Klinik Keperawatan
- b. Ketidak hadirannya Praktek Klinik Keperawatan karena sakit atau ijin lebih dari 10% dari jumlah kehadiran yang seharusnya di masing-masing bagian/bidang keperawatan, dinyatakan tidak lulus pada bagian/bidang tersebut dan harus mengulang kembali praktek dengan seijin Koordinator Praktek Klinik Keperawatan
- c. Ketidak hadirannya Praktek Klinik Keperawatan tanpa keterangan (Alpa), dapat dinyatakan tidak lulus pada bagian/bidang keperawatan yang ditinggalkan dan harus mengulang kembali praktek dengan seijin koordinator Praktek Klinik Keperawatan

a.n. Plt. Direktur
Ketua Jurusan Keperawatan



Dr. Erlina Suci Astuti, S.Kep.Ns., M.Kep.

JADWAL PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN BAGI MAHASISWA KELAS RPL SEMESTER VIII
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN MALANG
JURUSAN KEPERAWATAN POLTEKKES KEMENKES MALANG
TAHUN AKADEMIK 2025/2026 DI RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

TANGGAL KELOMPOK	1	2	3	4	5	6	7	8
	20-25 April 2026	27April – 2 Mei 2026	4-9 Mei 2026	11-16 Mei 2026	18-23 Mei 2026	25-30 Mei 2025	1-6 Juni 2026	8 Juni – 4 Juli 2026
KEL 7 1. PUTRI ALIVIAH KURNIAWATI	Gadar & Kritis R. ICU RS Prima Husada Sukorejo	Gadar & Kritis R. ICU RS Prima Husada Sukorejo	Kep. Paliatif R. Paliatif RS Prima Husada Sukorejo	PK Peri-operatif R. IBS RS Prima Husada Sukorejo	PK Peri-operatif R. IBS RS Prima Husada Sukorejo	PK Peri-operatif R. IBS RS Prima Husada Sukorejo	PK Peri-operatif R. IBS RS Prima Husada Sukorejo	Skripsi

a.n. Plt. Direktur
Ketua Jurusan Keperawatan,



Dr. Erlina Suci Astuti, S.Kep.Ns., M.Kep